Síndromes pleurales

SEMIOLOGIA · Clase 04 · derrame, neumotórax y hemoneumotórax

1 · QUÉ OCUPA LA PLEURA: LÍQUIDO, AIRE O SANGRE

Cavidad pleural
normal: apenas 3–5 ml de líquido; más que eso, o aire, la ocupa

si pasa de 5 ml se forma el

si entra aire se forma el

F8
Trasudado: presión, sin lesión de la pleura
insuficiencia cardíaca derecha, cirrosis, hipoproteinemia, nefrótico, mixedema, lupus, Meigs. En el cardiópata, a la derecha (decúbito lateral derecho)

por presión a distancia, un

Derrame pleural
líquido libre o tabicado por encima de 3–5 ml

separa el pulmón de la pared:

si abajo hay sangre es un

Hemoneumotórax
aire arriba y sangre abajo, típico del politraumatizado; con líquido: hidroneumotórax, con pus: pioneumotórax

aire arriba y sangre abajo dan el

Exudado: lesión directa de la pleura
TBC, neumonía mal tratada, neoplasia, embolia pulmonar

por daño de la propia pleura, un

Neumotórax
aire acumulado en la cavidad pleural

colapsa el pulmón hacia el hilio:

El pulmón se aleja de la pared
el líquido lo comprime y el aire lo colapsa hacia el hilio: vibraciones y murmullo se apagan en los tres

F11
Rotura de bula
causa más frecuente del neumotórax espontáneo: joven, dolor súbito «como puñalada»

al romperse deja entrar aire:

Traumatismo
fractura costal, herida penetrante, biopsia pleural

al abrir la pared deja entrar aire:

se confirma con la → 3 · EL MEDIASTINO: EMPUJA O JALA

si se acumula líquido se forma el → 2 · QUÉ SE ENCUENTRA: VIBRACIONES, PERCUSIÓN Y MURMULLO

2 · QUÉ SE ENCUENTRA: VIBRACIONES, PERCUSIÓN Y MURMULLO

F12
Hemoneumotórax
hipersonoro en los 2/3 superiores y mate en el 1/3 inferior

al auscultar deja el

al mirar y palpar deja

a la percusión da

F1 · F2 · F3 · F9
Murmullo vesicular abolido
en el neumotórax, silencio respiratorio

al separar las hojas, el dolor

si se infecta o crece, puede dar → 4 · EVOLUCIÓN: DEL ROCE AL DERRAME Y AL NEUMOTÓRAX A TENSIÓN

en el borde del líquido, la voz da

F1 · F2 · F3
Percusión del derrame: matidez intensa
límite superior parabólico, más alto en la axila: curva de Damoiseau

F4
Egofonía
voz como balido de cabra, en el pulmón comprimido del borde: derrame de volumen mediano

sin murmullo completa la

con Damoiseau completa la

y a sus lados, los triángulos de

más arriba, una capa fina da el

F1 · F2 · F9
Inspección y palpación
abombamiento del hemitórax, expansibilidad disminuida, vibraciones vocales disminuidas o abolidas

Garland y Grocco
Garland: triángulo hipersonoro sobre la curva; Grocco: triángulo mate en la base del lado sano

a la percusión da

si es mediano suma a la

F9
Percusión del neumotórax: timpanismo
el aire libre resuena como un tambor

F5
Soplo pleurítico
suena como una «E» bajo la axila, sobre una capa fina de líquido

si hay fístula al bronquio, el

Soplo anfórico
solo en el neumotórax con fístula broncopleural: resuena como una garrafa

con la curva suma a la

igual de abombado en la

se suma a la matidez en la

con el silencio completa la

en el borde suma a la

sin ventilación completa la

si hay fístula suma a la

Firma del derrame
abombamiento, vibraciones abolidas, matidez con Damoiseau y murmullo abolido

Firma del neumotórax
vibraciones abolidas, timpanismo y silencio respiratorio

vs neumotórax: solo cambia el sonido:

vs derrame: solo cambia el sonido:

F10
La percusión los separa
vibraciones y murmullo se apagan en ambos: líquido mate, aire timpánico

3 · EL MEDIASTINO: EMPUJA O JALA

Radiografía del derrame
borra el seno costodiafragmático; menos de 300 ml pasa inadvertido de pie y se ve en decúbito lateral

si hay mucho líquido da el

F6
Derrame voluminoso
ocupa volumen y empuja el mediastino y la tráquea al lado sano: velamiento con desviación opuesta

ocupa volumen y por eso

empuja, a diferencia de la

F7
Atelectasia
el pulmón pierde volumen: jala el mediastino al mismo lado y retrae los espacios intercostales; también da matidez y vibraciones abolidas

F14
Fibrotórax (pleuritis crónica o paquipleuritis)
engrosamiento fibroso: retrae el hemitórax; vibraciones y murmullo disminuidos, submatidez o matidez

si se cronifica deja un

pierde volumen y por eso

retrae el hemitórax y por eso

F7
Decide el mediastino
el derrame empuja al lado sano; la atelectasia jala y el fibrotórax retrae

4 · EVOLUCIÓN: DEL ROCE AL DERRAME Y AL NEUMOTÓRAX A TENSIÓN

El líquido separa las hojas: el dolor desaparece y se vuelve peso (gravativo); la disnea empeora

Complicaciones del derrame
empiema e insuficiencia respiratoria

Pleuritis aguda
las dos hojas inflamadas se rozan: dolor punzante que sube con tos e inspiración, y frote pleural

para tipificarlo se hace la

Inicio súbito
dolor «como puñalada», tos seca y disnea; cianosis si es grave

de inicio súbito da la

si el aire queda atrapado a presión

Neumotórax hipertensivo
el aire queda a presión: mediastino desviado, diafragma aplanado y espacios intercostales ensanchados

sin tratar lleva a la

Insuficiencia respiratoria aguda
hasta 30 % de mortalidad sin tratamiento

5 · TORACOCENTESIS: CONFIRMAR Y TIPIFICAR EL LÍQUIDO

Toracocentesis
diagnóstica (causa del derrame) y terapéutica (alivia hasta 1 500 ml); no se hace con infección de la piel en el sitio

se punza sentado en el

Sitio de punción
sentado, 8.°–9.° espacio intercostal detrás de la línea axilar posterior, rasando el borde superior de la costilla

el líquido extraído se reparte:

F13
Reparto del líquido
10 ml parasitológico, 10 ml bacteriológico, 10 ml bioquímico y 20 ml de reserva

a simple vista tiene un

para el estudio bacteriológico:

F13
Bacteriológico
Gram tras centrifugar, cultivo para aerobios y anaerobios, baciloscopia, hongos y cultivo de bacilo de Koch

Aspecto del líquido
trasudado claro y amarillo pálido; exudado opaco; sanguinolento en mayores de 60 años: neoplasia; purulento: empiema

busca el germen y ayuda a

orienta a trasudado o exudado:

El análisis del líquido distingue trasudado de exudado y orienta la causa

se distingue del exudado por el

concepto · causa · síndrome · ejemplo · mecanismo · signo · desenlace · diagnóstico · síntoma · complicación · técnica · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Sotomayor, apuntes de Semiología Médica 2020, tema 7 (Aparato respiratorio) — clases 07e, 07c, 07d y 07g